

1. Concernant le diagnostic de la Covid-19, quelles sont les affirmations fausses ?

- A - L'absence de symptômes élimine l'infection
- B - Une PCR négative élimine l'infection
- C - Un test rapide antigénique négatif élimine l'infection
- D - La TDM thoracique normale élimine l'infection
- E - une sérologie négative élimine l'infection

2. Les deux signes cliniques les plus fréquents dans la Covid-19 sont

- A - Anosmie
- B - Agueusie
- C - Fièvre
- D - Diarrhée
- E - Toux

3. Les critères d'alerte au cours de la surveillance des paramètres chez un patient infecté par la Covid-19 sont :

- A - Pression artérielle à 100/60 mmhg
- B - Température à 38°C
- C - Saturation en oxygène à 94% en air ambiant
- D - Fréquence cardiaque à 80 battements par minute
- E - Fréquence respiratoire à 25 cycles par minute au repos

4. La prévention de la transmission de l'infection en milieu de soins repose sur.

- A- Se laver fréquemment les mains
- B- Maintenir une distance d'au moins 1 m
- C- Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas d'éternuement
- D- Porter un masque
- E- Être vacciné contre le virus

5. Les facteurs de risque d'une maladie Covid-19 grave sont.

- A- Age > 40 ans
- B- Diabète compliqué
- C- Indice de masse corporelle > 40
- D- Grossesse
- E- Insuffisance rénale aiguë

6. Le malade nécessite une oxygénothérapie aux lunettes. Quel débit maximal est possible avec cette interface ?

- A- 3 L/min
- B- 4 L/min
- C- 5 L/min
- D- 6 L/min
- E- 7 L/min

7. La levée de l'isolement après infection est autorisée après combien de jour du début des symptômes ?

- A - J7
- B - J10
- C - J14
- D - J21
- E - J28

8. Après le soin à un patient porteur de la Covid-19 dans quel ordre effectuez-vous les gestes suivants ? 1 Retirer la blouse. 2 Retirer les lunettes. 3 retirez les gants. 4 Effectuer l'hygiène des mains 5 Retirer le masque

- A - 12345
- B - 35421
- C - 23154
- D - 32154
- E - 42135

9. Les caractéristiques fondamentales d'un soin sont :

- A- Le respect de la dignité
- B- La satisfaction du patient
- C- L'éducation
- D- La sécurité
- E- La réactivité

10. La gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques :

- A- Les déchets médicaux sont classés en quatre catégories
- B- Ils doivent dès leurs générations être triés
- C- Ils doivent être stuqués dans le service puis triés immédiatement avant de les transportés
- D- Le tri se fait selon les catégories et dans des sacs et receptions de couleurs différentes
- E- Toutes les réponses sont fausses

11. Dans un ECG normal ACD

- A- l'onde P correspond à la dépolarisation des oreillettes
- B- l'onde P correspond à la repolarisation des oreillettes
- C- Elle doit précéder chaque complexe QRS
- D- Elle est négative en avR

12. Dans un ECG normal. (C)

- A- La fréquence est comprise entre 40-120/mn
- B- La fréquence est comprise entre 40-100/mn
- C- La fréquence est comprise entre 60-100/mn
- D- La fréquence est comprise entre 60-130/mn

13. Dans un ECG normal. (ABC D)

- A- tous les incidents électriques doivent être négatifs en avR
- B- L'onde P sinusale est positive en DI-DII
- C- l'onde R pousse de façon harmonieuse de V1 à V6

● D- Chaque QRS est précédé d'une seule onde P

14. Dans un ECG normal (A)

- A- L'intervalle P-R (ou P-Q) a une durée constante (0,12 à 0,20 s)
- B- L'intervalle P-R (ou P-Q) a une durée constante (0,10 à 0,20 s)
- C- L'intervalle P-R (ou P-Q) a une durée constante (0,20 à 0,40 s)
- D- L'intervalle P-R (ou P-Q) a une durée constante (0,20 à 0,50 s)

15. L'onde T. (BCD)

- A- Traduit la repolarisation auriculaire
- B- Est précédé du segment ST
- C- Est de morphologie asymétrique
- D- Est négative en aVR

16. Le complexe QRS. (AB)

- A- Correspond à la dépolarisation ventriculaire
- B- Est d'une durée inférieure à 0,12 s
- C- Est toujours à prédominance positive
- D- Est toujours à prédominance négative

17. L'œdème aigu pulmonaire (ABD)

- A- Se manifeste par une détresse respiratoire aiguë
- B- Est une manifestation d'insuffisance cardiaque gauche
- C- Survient à l'effort
- D- Peut s'accompagner d'hémoptysie

18. L'orthopnée (CD)

- A- Survient à l'orthostatisme
- B- Survient à l'effort
- C- Survient en décubitus
- D- Est un signe d'insuffisance cardiaque

19. Un souffle cardiaque évoque en 1er lieu (B)

- A- Une insuffisance cardiaque
- B- Une valvulopathie
- C- Une péricardite
- D- Un infarctus du myocarde

20. A quel (s) diagnostic(s) faut-il penser en premier devant un patient de 65 ans qui consulte pour une douleur thoracique aiguë ? (ABCD)

- A- Un infarctus du myocarde
- B- Une dissection aortique
- C- Une Embolie pulmonaire
- D- Une Péricardite aiguë

21. Parmi ces choix, qu'est-ce qu'on entend par produits sanguins labiles (PSL) ?

- A. Les culots globulaires
- B. Les culots plaquettaires
- C. Les facteurs anti-hémophiliques
- D. Le plasma frais congelé

22. Quel est le rôle de l'infirmier en cas de demande de PSL ?

- A. Remplir la demande des PSL.
- B. Valider la demande des PSL.
- C. Prélever le malade pour demande de PSL.
- D. Envoyer la demande de PSL.

23. Quel est le rôle de l'infirmier après la réception des PSL, de la banque de sang ?

- A. Réceptionner les PSL.
- B. Informer le médecin de la qualité des PSL.
- C. Remplir la fiche d'anomalies en cas de constatation d'une anomalie qualitative des PSL. reçus
- D. Rien, puisque la réception des PSL relève des fonctions du médecin

24. Quel est le rôle de l'infirmier avant l'acte transfusionnel ?

- A. Vérifier la concordance entre le groupage du malade et celui du PSL reçu
- B. Vérifier la concordance entre l'identité du malade et l'identité du receveur pour lequel le PSL a été livré
- C. Réaliser la carte de contrôle pré-transfusionnel
- D. Transfuser directement les PSL, puisque les vérifications relèvent des fonctions du médecin

25. en cas de réception de 3 CGR pour le même malade, comment réaliser la carte de contrôle pré-transfusionnel ?

- A. Réaliser la carte au lit du malade
- B. Réaliser la carte pour tous les CGR reçus dans la salle des soins
- C. Réaliser la carte pour le CGR à transfuser (un par un)
- D. L'acte transfusionnel est assuré par l'infirmier qui a réalisé la carte

26. Quel est le rôle de l'infirmier lors de l'acte transfusionnel ?

- A. Valider l'acte transfusionnel
- B. Réaliser l'acte transfusionnel
- C. Surveiller la transfusion
- D. Avertir le médecin en cas d'incident transfusionnel

27. Quelles sont les éléments qu'il faut surveiller lors de l'acte transfusionnel ?

- A. L'apparition de signes rapportés par le malade au cours ou au décours immédiat de la transfusion
- B. L'état hémodynamique toutes les 10 min au cours des 30 premières minutes puis de manière espacée
- C. L'apparition de fièvre
- D. Rien, puisque la surveillance de l'acte transfusionnel relève des fonctions du médecin

28. Quelle est la durée de transfusion maximale qu'il ne faut pas dépasser pour un culot globulaire ?

- A. 30 min
- B. 1 heure
- C. 1h 30 min
- D. 2 heures

29. En cas de transfusion de plusieurs types de produits sanguins labiles, quel est l'ordre qu'il faut respecter ?

- A. CGR puis CPS puis PFC décongelés
- B. CPS puis PFC décongelés puis CGR
- C. PFC décongelés puis CPS puis CGR
- D. CPS puis CGR puis PFC décongelés

30. En cas d'incident transfusionnel, que doit faire l'infirmier ?

- A. Arrêter la transfusion et avertir le médecin
- B. Arrêter la transfusion, avertir le médecin et prendre les constantes
- C. Avertir le médecin
- D. Rien, puisque la surveillance de l'acte transfusionnel relève des fonctions du médecin

31. La rétention urinaire complète et aigue :

- A- Est Une urgence urologique
- B- Nécessite un traitement médicamenteux
- C- Se manifeste par une douleur avec impossibilité d'uriner
- D- Se manifeste par une impossibilité d'uriner sans douleur
- E- Nécessite la mise en place d'un drainage vésicale

32. Le cancer urologique le plus fréquent chez l'homme de plus de 50 ans :

- A- Cancer de vessie
- B- Cancer du rein
- C- Cancer de l'urètre

- D- Cancer de prostate
- E- Cancer testiculaire

33. L'hématurie :

- A- Est la présence du sang dans le sperme
- B- Est un saignement urétral en dehors des mictions
- C- Est la présence du sang dans les urines
- D- Peut être en rapport avec un cancer de vessie
- E- Peut être en rapport avec une infection urinaire

34. L'hypertension artérielle peut être secondaire à :

- A- Une maladie rénale
- B- Une tumeur des glandes surrénales
- C- Un cancer du rein
- D- Un cancer de vessie
- E- Une infection urinaire

35. Le diagnostic d'une infection urinaire est confirmé par :

- A- La numération formule sanguine
- B- L'ionogramme complet
- C- La cytologie urinaire
- D- La bandelette urinaire
- E- L'examen cyto bactériologique des urines

36. Le sondage vésical :

- A- Est un geste simple ne nécessitant pas de précautions particulières
- B- Est indiqué chez tout malade ayant des difficultés à uriner
- C- Est indiqué en cas de rétention complète d'urine
- D- Le matériel utilisé n'est pas obligatoirement stérile
- E- L'infection urinaire en est une complication majeure

37. La principale cause du cancer de la vessie est :

- A- L'alcool
- B- La consommation excessive des viandes rouges
- C- Le tabac
- D- Infection urinaire
- E- Le diabète

38. Les patients porteurs de sondes vésicales à demeure :

- A- Ne nécessitent aucune surveillance particulière
- B- Les soins de sonde sont indispensables chez eux
- C- Ont un risque important d'infection urinaire
- D- Nécessitent un changement de sonde régulièrement
- E- Le changement de sonde ne nécessite pas obligatoirement des règles d'asepsie

39. La fièvre associée à une douleur lombaire chez un patient porteur d'une lithase rénale :

- A- Il s'agit fort probablement d'une infection rénale
- B- La situation clinique n'est pas inquiétante
- C- Il s'agit d'une urgence thérapeutique
- D- Nécessite un prélèvement urinaire pour étude bactériologique
- E- Le traitement repose sur l'administration du seul paracétamol

40. Suite à une intervention chirurgicale, un patient présente une hypotension sévère, pouls faiblement perceptible, des sueurs et une froideur des extrémités :

- A- Il s'agit d'un état de choc
- B- Ce tableau clinique peut être en rapport avec une hémorragie
- C- Il peut s'agir d'un état de choc septique
- D- La transfusion est obligatoire dans tous les cas
- E- Nécessite une prise en charge en réanimation.